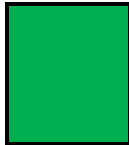
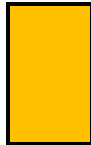


 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTEK KLINIS (PPK) TINDAKAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2024
PERSALINAN PADA LETAK SUNGSANG	
Pengertian (Definisi)	Persalinan spontan pada letak bokong dengan seluruhnya memakai kekuatan tenaga ibu sendiri Terdiri dari 3 tahap • Tahap pertama : fase lambat yaitu lahirnya bokong sampaidengan pusat (scapula depan) • Tahap kedua : fase cepat yaitu lahirnya pusat sampailahirnya mulut • Tahap ketiga : fase lambat yaitu lahirnya mulut sampaidengan seluruh kepala
Indikasi	Presentasi bokong murni, bokong kaki sempurna (complete breech), dan bokong tidak sempurna (incomplete breech)
Kontra indikasi	1. Didapatkan fetopelvic disproportion (berat badan janin > 3500gr) 2. Pada bekas <i>Sectio Caesarea</i> (SC) 3. Pada panggul sempit 4. Pada prematuritas 5. Pada <i>High Social Valuable Baby</i> (HSVB) 6. Pada primi tua 7. Pada <i>Bad Obstetrical History</i> (BOH) 8. Pada <i>fetal compromised</i>
Syarat	1. Dilatasi cervix lengkap 2. Selaput ketuban telah pecah atau dilakukan amniotomy 3. Tidak ada fetopelvic disproportion 4. Tidak ada kelainan jalan lahir 5. Tidak ada kelainan janin
Persiapan	Persiapan pasien : – Persetujuan Tindakan Medik – Pemeriksaan darah lengkap, USG, Kardiotokografi – Konsul perinatologi untuk persiapan tim resusitasi neonatus Persiapan Alat – Bed ginekologi – Sarung tangan – Apron – Sepatu boot – Masker – <i>Google</i> – <i>Cap</i> – Partus set – Lampu sorot – <i>Neonatal resuscitation table</i> – <i>Resuscitation set</i> – <i>Hecting set</i> – Stetoskop – Doppler – Doek steril Persiapan Bahan – S spuit 3 cc – S spuit 5 cc – Lidocain Amp – Saflon – <i>Povidone Iodine</i> – Kasa steril – Kapas steril – Oksigen

	Persiapan Penolong/operator : – <i>Informed consent</i> – Alat Pelindung Diri (APD) – Cuci tangan 6 langkah
Prosedur	1. Menyambut dengan sopan, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, <i>Informed consent</i> secara lisan 2. Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis 3. Menjaga privasi dan memposisikan klien 4. Memakai APD (apron, cap, <i>google</i>, masker, sepatu) 5. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan memakai sarung tangan 6. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan memimpin meneran bila ada his 7. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam secara <i>bracht</i> (kedua ibu jari penolong sejajar dengan paha, jari-jari yang lain memegang daerah panggul) 8. Tidak melakukan penarikan bokong, tidak melakukan intervensi dan ikuti proses keluarnya janin sesuai kurve jalan lahir sambil ibu dipimpin meneran saat ada his 9. Injeksi oksitosin 5 IU IM fasies lateralis regio femoralis 10. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada (segera memposisikan kembali kedua tangan penolong mencengkam bokong janin) 11. Lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak dibawah simfisis (dengan mengikuti gerak rotasi anterior yaitu punggung janin di dekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan) di sesuaikan dengan lahirnya badan janin, hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi dan kepala bayi lahir 12. Meletakkan bayi di atas perut ibu sambil melakukan penilaian sepiantas (warna kulit, bayi menangis kuat, pergerakan aktif) 13. Menjepit tali pusat dengan klem 3 cm dan 5 cm didepan umbilicus, tali pusat dipotong diantara 2 klem 14. Melakukan manajemen aktif kala III (lihat manual prosedur untuk manajemen aktif kala III) 15. Menyelesaikan tindakan dengan sempurna (membersihkan alat-alat dengan merendam ke dalam larutan Klorin 0,5% lalu mencuci sarung tangan kedalam larutan Klorin 0,5% dan melepasnya secara terbalik) 16. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan melepaskan APD 17. Memberitahukan hasil tindakan kepada ibu dan suami/keluarga 18. Dokumentasi di rekam medis
Komplikasi	1. Ruptura portio 2. Gawat janin 3. Laserasi perineum
Kriteria Pulang	2 hari perawatan
Tingkat Evidens	
Tingkat Rekomendasi	
Penelaah Kritis	1. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG 2. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG 3. dr. Mulyo Hadi Wibowo, Sp. OG
Indikator Tindakan	1. Mampu melakukan langkah langkah persalinan letak sungsang dengan benar dan berurut 2. Tidak didapatkan komplikasi dan kontra indikasi
Kepustakaan	1. Wiknjosastro GH, Saifuddin AB, Rachimhadhi T, editors. 2010. <i>Ilmu Bedah Kebidanan Sarwono Prawirohardjo</i>. Ed 6. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

	2. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. 2018. <i>Breech Delivery</i> . In: william obstetrics. 25 th eds. New York: McGraw-Hill Education
Pasuruan, 04 Juni 2024 Mengetahui, Direktur RS Prima Husada Sukorejo dr. Ifit Bagus Apriantono	

CLINICAL PATHWAY

PARTUS SUNGSANG**Keterangan:****Yang harus dilakukan:****Bisa ada atau tidak:**

TRUE

Beri tanda

: Bila sudah dilakukan

Kesimpulan

: Medis (Dokter) : TIDAK PATUH
 : Keperawatan : TIDAK PATUH
 : Gizi : TIDAK PATUH
 : Farmasi : TIDAK PATUH

TIDAK PATUH**MEDIS (DOKTER)**

KEGIATAN AN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERA NGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. ASESMEN AWAL	Dokter Umum								
	Dokter Spesialis (DPJP)								
2. ASESMEN LANJUTAN	Pemeriksaan DPJP								Visite dokter
	Co-Dokter jaga								Jika ada indikasi
3. LABORAT ORIUM									
	Darah Lengkap								
4. RADIOLO GI / IMAGING	NST								
	USG								Jika diperlukan
5. Konsultasi	Spesialis Obgyn								
6. TATA LAKSANA MEDIS									
Medikamentosa									
7. Injeksi	Oxitosin 10 iu								
	Metergin 1 amp								
	Lidocain								
	Asam Traneksamat								Jika Diperlukan
9. Cairan Infus	RL / NS / D5								

10. Obat Oral	Amoxicilin								Obat pulang
	Asam Mefenamat 500 mg								Obat pulang
	Methylergometrin								obat pulang
12. Tindakan	Partus Sungsang								
13. Dokter DPJP	Monitoring tanda vital								
	Monitoring luka								
14. Informasi & Edukasi	Diagnosis, Rencana terapi/tindakan, Risiko, Komplikasi,								oleh DPJP
15. Pengisian Form	Informed Consent								DPJP
	Lembar Edukasi								Seluruh PPA bersama Pasien
	1. Tirah Baring, miring kanan, miring kiri, duduk								Mobilisasi bertahap
16. MOBILISASI	2. Aktivitas harian								
EVALUASI OUTCOME									
17. Keluhan	Nyeri daerah jalan lahir								
18. Pemeriksaan Klinis	Tinggi fundus uteri								
	Uterus Kontraksi								
	Luka jahitan perenium								
	Perdarahan pervaginam								
19. Lama rawat	Sesuai PPK								
20. Discharge Planning	discharge risk assesment, penatalaksanaan								oleh MPP
21. Ringkasan Pulang	Pembuatan Resume, Ringkasan Pulang, penjelasan								Oleh DPJP

KESIMPULAN :

Nama DPJP	
Kategori	TIDAK PATUH

Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :

GIZI

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian awal asuhan	1. Data Subjektif								
	a. Lihat resiko								
	b. Mengkaji data								
2. Intervensi Gizi	1. Diagnosis Gizi								
	NI-2.1								Sesuai dengan data asesmen, kemungkinan saja ada diagnosis
	kurang berkaitan								
	NI.5.10.1								
	Kekurangan intake Fe								
	NB-1.5								
	Kekeliruan pola makan								
	2. Edukasi dan Konseling Gizi								
	Diet pasca partus normal / diet ibu menyusui tinggi energi dan tinggi protein sesuai dengan kebutuhan.								Edukasi gizi dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan awal, atau dapat juga dilakukan pada hari ke 4 atau hari ke 5 saat pasien akan pulang.
	3. Tata Laksana / Intervensi								
	a. Diet Tinggi Energi								Bentuk Makanan, kebutuhan
	b. Memberikan								
	4. Monitoring dan Evaluasi (Monitor Perkembangan Pasien)								
	makan								Sesuai dengan masalah gizi dan
	antropometri								
	c. Monitoring Biokimia								
	d. Monitoring fisik / klinis terkait gizi								Mengacu pada
	5. Hasil								
	a. Asupan Makan >80%								Status gizi optimalisasi diet
	b. Optimalisasi status								

KESIMPULAN :

Nama KaRu

Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :

Kategori

TIDAK PATUH

FARMASI

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HARI PENYAKIT							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian Awal Asuhan Kefarmasian di Rawat	1. Data Subjektif								
	a. Riwayat Alergi Obat								
	Pasien								
	Samping Obat								
2. Intervensi Farmasi	1. Asesmen Farmasi								Dilanjutkan dengan intervensi farmasi
	a. Telaah Resep								Memingkatkan kepatuhan
	b. Rekonsiliasi Obat								sesuai dengan hasil
	2. Edukasi Farmasi								Dilanjutkan dengan intervensi farmasi yang sesuai
	a. Informasi Obat								Memingkatkan kualitas hidup
	b. Konseling Obat								Memingkatkan kepatuhan minum
	Sesuai Jenis dan								
	3. Tata Laksana/ Intervensi Farmasi								
	DPJP								
	4. Monitoring dan Evaluasi								
	a. Monitoring Interaksi Obat								
	b. Monitoring Efek Samping Obat								
	c. Pemantauan Terapi Obat								
	d. Kepatuhan Pasien Minum Obat								
	5. Hasil								
	a. Terapi Obat Sesuai Indikasi								
	b. Obat Rasional								
	6. Ringkasan Pulang								
	a. Terapi Obat Pulang								
	b. Edukasi Obat Pulang								

KESIMPULAN :

Nama KaRu	
Kategori	TIDAK PATUH

Variasi yang menyebabkan anda tidak mematuhi CP :

KEPERAWATAN

HARI PENYAKIT			
---------------	--	--	--

KEGIAT AN	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	KETERA NGAN
		HARI DIRAWAT							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Pengkajian awal keperawata n rawat inap	1.data subjektif								
	mengeluh nyeri								
	2.data objektif								
	meringis,bersikap								
2, Intervensi	1. nyeri akut								
keperawa tan									
	nyeri akut								
	pemberian obat-obatan								
	(mis:tekanan darah								
	lokasi,karakteristik,dura								
	e. identifikasi skala nyeri								
	nyeri non verbal								
	memperberat dan								
	pengetahuan dan								
	Terapeutik								
	nonfarmakologis untuk								
	yang memperberat rasa								
	tidur								
	untuk pemeriksaan								
	dan sumber nyeri								
	Edukasi								
	a. jelaskan								
	b. jelaskan strategi								
	c. Anjurkan memonitor								
	d. anjurkan teknik								
	Kolaborasi								
	pemberian								
	2.nausea								
	nausea								
	pemberian makanan								
	(mis:merasa asam								
	pengalaman mual;								
	penyebab mual								
	mual(mis:frekuensi,dura								
	nutrisi dan kalori								
	mual								
	Terapeutik								
	lingkungan penyebab								

	hilangkan keadaan								
	dalam jumlah kecil dan								
	dingin,cairan								
	Edukasi								
	a. anjurkan istirahat								
	b. anjurkan sering								
	c. Anjurkan makanan								
	d. ajarkan penggunaan								
	Kolaborasi								
	a. Kolaborasi pemberian anti emetic								bila perlu

**KESIMP
ULAN :**

Nama KaRu	
Kategori	TIDAK PATUH

**Variasi yang menyebabkan anda
tidak mematuhi CP :**